Processo nº 0067076-67.2024.8.17.2001

AUTOR(A): MARIA RAFAELA DE ALBUQUERQUE COSTA

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência** ajuizada por **MARIA RAFAELA DE ALBUQUERQUE COSTA TRINDADE**, advogando em causa própria (carteira da OAB nos IDs 174370138 e 174370140), em face da **CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI**, igualmente qualificada, informando, à saída, que tem interesse na realização de audiência prévia de conciliação ou de mediação (art. 319, VII, do CPC/2015).

A autora afirma que é segurada da operadora de planos de saúde (OPS) ré – Produto CASSI Família I, número do cartão 1001004259560008 (ID 174370143) – adimplente com as mensalidades (ID 174370145), e sofre de **enxaqueca crônica – MIGRÂNEA REFRATÁRIA CRÔNICA** (CID-10 G43.9) – com vários tratamentos sem sucesso, idas frequentes à urgência, o que vem impactando negativamente em sua qualidade de vida de forma geral, inclusive no âmbito profissional, razão pela qual o neurologista Marcos Eugênio Ramalho Bezerra, CRM-PE 17405, RQE 5237 (laudo de ID 153656202), prescreveu o uso de "***ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-CGRP – FREMANEZUMAB (AJOVY) 150MG/ML – 01 frasco 1x mês*****" (receituário de ID 174370147**).

Declara que o prestador responsável pelo fornecimento da medicação e respectiva administração (Clínica Autoimune) fez a solicitação administrativa à OPS, ao que adveio a negativa da ré, sob a justificativa de que a patologia da demandante não é coberta pelo contrato (IDs 174370150 e 174370152).

Contudo, a autora assevera que o contrato celebrado tem cobertura para tratamento especializado, "*Cláusula dos Serviços Cobertos*", e transcreve a "*Cláusula 6º, item d*" do contrato (não juntado aos autos). Ademais, informa que a medicação é registrada na ANVISA (nº 1557300500026), e que possui em sua bula indicação para o tratamento preventivo de enxaqueca para adultos com pelo menos 4 dias de enxaqueca por mês, conforme informação extraída no sítio da ANVISA.

Dado ao narrado, propõe a presente demanda. Pugna pela concessão liminar da tutela provisória de urgência antecipada para compelir a ré a custear integralmente todo o tratamento médico prescrito. Ao final, além da confirmação da tutela, requer a condenação da ré em indenizar

por danos morais na quantia de R$ 10.000,00, sendo este o valor atribuído à causa, e sobre o qual pagou as custas judiciais (ID 174379112).

Decisão de ID 174663551 determina a emenda à inicial a fim de a parte autora corrigir e alterar o valor da causa para que corresponda a uma anuidade do tratamento.

A parte autora atravessa petição informando que o valor de cada frasco é no importe de R$ 1.208,99, totalizando a quantia de R$ 14.507,88, acrescido do dano moral de R$ 12.000,00, alcança a monta de R$ 26.507,88. Pontua, ainda, que o valor das custas e taxa judiciária importam na quantia total de R$ 530,16, e, como já efetuou o pagamento de R$ 295,40, resta apenas a título de custas complementares o valor de R$ 234,76.

Postula pela alteração do valor da causa para R$ 26.507,88.

Decisão de ID 179920398: (i) recebe a emenda à inicial, determinado a alteração do valor da causa para R$ 26.507,88, com intimação da parte autora para pagamento das custas complementares; (ii) concede a tutela antecipada para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento medicamentoso com Fremanezumabe (Ajovy) 225 mg, solução injetável; (iii) determina a citação da ré para, querendo, apresentar defesa.

A requerida informa o cumprimento da tutela e junta documentação comprobatória (ID 181195151 - Pág. 1; 181195153 - Pág. 1; 181195154 - Pág. 1 e 181195155 - Pág. 1).

A **Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi** apresenta **contestação** no ID 182383301, aduzindo, para tanto, em síntese, o seguinte: (i) a parte autora é beneficiária de contrato antigo e não adaptado à lei 9.656/98, não havendo previsão de cobertura para medicamento de uso domiciliar no contrato celebrado; (ii) os planos novos e adaptados também não possuem cobertura para remédio domiciliar, por força do art. 10, VI, da Lei 9.656/98; (iii) inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ; (iv) para os contratos antigos e não adaptados à lei dos planos de saúde, deve ser seguido o que se encontra no contrato, e, nos termos da cláusula 17, há exclusão para medicamentos de uso domiciliar; (v) a própria bula da medicação Ajovy prevê o uso domiciliar e a autoadministração pelo paciente, pontuando, ainda, que nos termos da jurisprudência do STJ é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, não tendo no caso vertente correlação com internação domiciliar ou aplicação por médico/enfermeiro; (vi) destaca que o evento não detém cobertura contratual e nem base legal, devendo ser indeferido, assim como o dano moral invocado, já que a ré não praticou ato ilícito.

Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados, e, acaso entenda pela procedência da demanda, que sejam considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na eventual condenação em danos morais.

A Cassi informa a interposição do Agravo de Instrumento nº 0048310-18.2024.8.17.9000, requerendo o exercício do juízo de retratação (ID 182501685).

Em seguida, a operadora requerida requer a título de produção de prova, a expedição de ofício à ANS para prestar dois esclarecimentos: (i) se é possível se falar de coberturas pela Lei 9.656/98 ou pelo Rol da ANS quando o contrato firmado é antigo e não adaptado à tal legislação; (ii)

se é possível que as Operadoras de saúde obriguem os usuários à adaptação do plano de saúde, com consequente aumento de sua mensalidade em relação aos planos novos adaptados?

A parte autora, por seu turno, apesenta réplica no ID 184547884, sem apontar outras provas a produzir. Registra, no entanto, que a aplicação da medicação é feita em ambiente hospitalar, inclusive precisa de temperatura específica para armazenamento, além de administração por profissional da saúde, e tanto é assim que a ré expediu autorização para o hospital credenciado, para ser feita a administração do fármaco, após deferimento da liminar.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a analisar e decidir.

Verifico que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC/2015.

Registro que o pedido de prova formulado pela parte demandada, consistente em ofício a ser expedido à ANS para dois esclarecimentos -- (i) se é possível falar de coberturas pela Lei 9.656/98 ou pelo Rol da ANS quando o contrato firmado é antigo e não adaptado à tal legislação; (ii) se é possível que as Operadoras de saúde obriguem os usuários à adaptação do plano de saúde, com consequente aumento de sua mensalidade em relação aos planos novos adaptados? – não se afigura necessário para o julgamento da lide, pois nos termos do Tema 123 do STF: *" As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados."*

Ademais, não se pode perder de vista que cada caso concreto posto em pretório haverá de ser solucionado de conformidade com as suas particularidades e a jurisprudência vigente acerca da temática.

No caso em liça, a matéria gira em torno da obrigatoriedade, ou não, de fornecimento de medicamento domiciliar **i**ntravenosa ou injetável, que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde.

Sendo assim, não se justifica, no caso em epígrafe, a expedição do ofício.

A questão central posta em análise centra-se em verificar se a operadora de saúde deve, ou não, fornecer a cobertura para a medicação prescrita à autora, pelo seu médico assistente: **aplicação fármaco Ajovy** (fremanezumabe) 150 mg/ml, solução injetável (1,5ml), com aplicação subcutânea, uma vez ao mês (receituário de ID 174370147).

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos da **Súmula 608** do STJ[1][1][1], o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao plano de saúde administrado por **entidade de autogestão**, como ocorre na hipótese dos autos.

Entretanto, conforme já esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tais entidades, "*embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, **não escapam ao dever de atender à função social do contrato***" (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

Verifica-se que a recusa de cobertura apresentada reside no fato de a medicação prescrita não ter cobertura contratual (ID 174370150 e 174370152), na medida em que: "*a participante não tem cobertura para o evento – Terapia Imunobiológica subcutânea ambulatorial" e "medicação sem cobertura".*

Ademais, por ocasião da contestação, suscita como tese de defesa o fato de haver expressa exclusão contratual para cobertura de fármaco para uso domiciliar (cláusula 17 das condições gerais), além do que ainda que incidisse ao caso a lei dos planos de saúde, não seria caso de cobertura, porquanto não se trata de tratamento de internação domiciliar e nem o medicamento necessita ser aplicado por profissional da saúde.

Em primeiro lugar, os documentos colacionados aos autos pela demandante, em especial o laudo do médico assistente, Dr. Marcos Eugênio Ramalho Bezerra, aponta a enfermidade que acomete a autora – CID G43.9 – quadro de **Migrânea Crônica Refratária**– e a indicação do tratamento medicamentoso com o fármaco Ajovy (fremanezumabe) 225 mg/1,5 ml, solução injetável.

No ponto, cabe reter que conforme jurisprudência pacífica do STJ, " *é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)."*

Do mesmo modo, resta assentado de forma uníssona, que "**A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)."** (**AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ**, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de **11/4/2024**.)

É esta a situação do caso em testilha, pois a medicação não se insere como sendo de uso domiciliar, na medida em que a própria ré, após a concessão da tutela, autorizou o fornecimento e aplicação do fármaco perante o Hospital Memorial São José, **a ser aplicado em ambiente ambulatorial**, ou seja, o medicamento AJOVY – 225 mg, solução injetável (1,5 ml), 01 frasco, para um mês (ID 181195154). Ademais, consta da autorização para procedimento, acostada pela operadora no ID 181195155, que o tratamento medicamentoso será efetuado em regime ambulatorial.

Deste modo, o caso da autora se insere na exceção preconizada pela jurisprudência atual e uníssona do STJ, inserindo-se como de uso ambulatorial, afastando o caráter domiciliar, porquanto se trata de fármaco intravenoso com necessidade de supervisão de profissional habilitado em saúde: *"**A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).**"*

Diante do exposto, resta evidenciado o dever da demandada de custear o procedimento prescrito pelo médico que assiste a autora.

Neste contexto, não se tratando de medicação de uso domiciliar, não há que ser aplicada a cláusula 17 das condições gerais.

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, este também é procedente.

Há de se pontuar que a parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que acometida de doença grave, necessitando submeter-se ao procedimento medicamentoso indicado.

Suportando a autora não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico com a não autorização não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu o demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral.

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL TIRADO DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PLANO DE SAÚDE. **RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA (IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO). DANO MORAL CONFIGURADO**. 1. **A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença**. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1614203 RJ 2016/0186519-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017).
>
> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.** PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. **DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1**. (...) 2**. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.** 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. **É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em**

regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. **(AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)**

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela parte autora, nos termos do art. 944, do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em **R$ 4.000,00 (quatro mil reais).**

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(1) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de obrigação de fazer, para **condenar a ré autorizar e custear o tratamento medicamentoso Fremanezumabe (Ajovy) 225 mg, solução injetável (1,5 ml), 01 frasco, uma vez ao mês,** a ser aplicado subcutâneo, nos termos do laudo de ID 174370146 e receituário de ID 174370147, **ratificando a tutela antecipada de ID 179920398**.

(2) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de indenização por danos morais, para condenar a demandada ao pagamento do valor de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais),** corrigidos monetariamente pela tabela ENCOGE a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e custos do medicamento- obrigação de fazer, com valor aferível, nos moldes da Súmula 199 do TJPE, referente a uma anuidade da medicação), na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Expeça-se ofício ao Desembargador Relator do **Agravo de Instrumento nº 0048310-18.2024.8.17.9000**, comunicando o conteúdo da presente sentença.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, proceda-se ao arquivamento dos autos.

P.R.I

Recife, 18 de outubro de 2024.

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
18/10/2024 18:36:03
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 185792573

24101818360293700000181208505

IMPRIMIR GERAR PDF